

Banque de questions — Santé Publique communautaire (L1)

BANQUE DE QUESTIONS — SANTÉ PUBLIQUE & SANTÉ COMMUNAUTAIRE

QCD et QCM classés par chapitre — Licence 1 · INFAS / Formation Plus

350 questions compilées et dédoublonnées — 197 QCD · 153 QCM

Sommaire

I. SANTÉ PUBLIQUE

Chapitre 1 — Introduction à la Santé Publique et Définitions des Concepts“CB VW7F–öç0

Chapitre 2 — Système National de Santé et Politique Nationale de Santé“Cb VW7F–öç0

Chapitre 3 — Programme Élargi de Vaccination (PEV)“S" VW7F–öç0

Chapitre 4 — Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)“b VW7F–öç0

Chapitre 5 — Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)“ VW7F–öç0

Chapitre 6 — Généralités sur l'Épidémiologie“C VW7F–öç0

Chapitre 7 — Surveillance Épidémiologique“R VW7F–öç0

II. SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Chapitre 1 — Étude du Milieu ou Monographie“# VW7F–öç0

Chapitre 2 — Hygiène et Assainissement du Milieu“CR VW7F–öç0

Chapitre 3 — Lutte contre les Vecteurs, Rongeurs et Nuisances Sonores“, VW7F–öç0

Chapitre 4 — Soins de Santé Primaires (SSP)“CR VW7F–öç0

Chapitre 5 — Communication pour le Changement Social de Comportement (CCSC)“3r VW7F–öç0

Chapitre 6 — Techniques d'Animation de Groupe“ VW7F–öç0

PARTIE I — SANTÉ PUBLIQUE

Chapitre 1 — Introduction à la Santé Publique et Définitions des Concepts

QCD — Questions à Choix Double (35)

1. Selon l'OMS, la santé est un état de bien-être physique uniquement.
2. Le niveau décisionnel de la santé publique se situe au niveau étatique.
3. La santé communautaire vise la promotion de la santé.
4. La santé communautaire et la santé publique sont deux approches identiques.
5. La finalité de la santé publique est la protection de la santé de la population.
6. La santé publique introduit une notion d'engagement de chaque individu membre de la communauté, alors que la santé communautaire recouvre la notion de pouvoir décisionnaire représentant de la population.
7. Selon l'OMS (2010), la plupart des déterminants de la santé se situent dans des secteurs autres que la santé.
8. L'étape « Adapter » consiste à contextualiser les données probantes dans la résolution d'un problème de santé publique.
9. Une politique de santé publique est constituée d'actions communautaires non coordonnées.
10. La santé communautaire se situe à un niveau gouvernemental.
11. En santé publique, la priorité est toujours la promotion de la santé.
12. Le concept de santé communautaire repose sur la participation et l'implication des communautés à toutes les phases d'intervention.
13. L'éducation à l'hygiène personnelle fait partie intégrante de la définition de la santé publique

selon l'OMS (1952).

14. Selon Winslow, la santé publique est un art et une science de prévention des maladies.
15. Le niveau de revenu et le soutien social sont des déterminants de santé.
16. La pollution et le chômage sont des facteurs de l'environnement physique uniquement.
17. La planification communautaire inclut la mobilisation et la coordination des ressources.
18. Une démarche de santé publique commence par une analyse de situation et l'identification des problèmes.
19. La démarche de la santé publique comporte 8 étapes.
20. La Charte d'Ottawa de 1986 marque un tournant pour la promotion de la santé.
21. Au Moyen Âge, la santé publique était centrée sur la prise en charge des maladies chroniques.
22. La priorité de la santé communautaire est la protection de la santé de la population.
23. La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.
24. Une action de santé publique est une opération collective et individuelle en vue de l'amélioration de la santé d'une population.
25. Une action de santé publique est une opération individuelle en vue de l'amélioration de la santé d'une population.
26. Un agent de santé communautaire (ASC) est une personne bénévole ayant une formation diplômante qui sert de relais entre la communauté et la structure sanitaire.
27. Une politique de santé publique est constituée d'actions communautaires non coordonnées.
28. Un Programme de santé est un ensemble coordonné d'actions ou de stratégies mises en œuvre pour atteindre un objectif.
29. Il existe trois types de prévention : la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire.
30. La prévention quaternaire est l'ensemble des soins auprès des malades qui ont dépassé le stade des soins curatifs et qui se trouvent en phase terminale (les soins palliatifs).
31. Publique désigne un groupe de personnes selon le dictionnaire Larousse.
32. La communauté est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion sociales.
33. La santé communautaire introduit une notion d'engagement de chaque individu membre de la communauté.
34. La promotion de la santé consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer leur santé.
35. Seuls les déterminants de santé négatifs influencent l'état de santé d'une population.

QCM — Questions à Choix Multiples (9)

1. Selon l'OMS (1946), la santé est :
 - A. L'absence de toute maladie
 - B. Un état de complet bien-être physique, mental et social
 - C. Une situation exclusivement médicale
 - D. Un état uniquement lié à la médecine curative
2. Parmi les éléments suivants, lesquels font partie des composantes de la santé publique selon Winslow (1920) ?
 - A. Prévention des maladies
 - B. Réanimation en urgence
 - C. Prolongation de la vie

D. Promotion de la santé par l'action collective

3. Sont des types de prévention en santé publique :

A. Prévention primaire

B. Prévention secondaire

C. Prévention curative

D. Prévention tertiaire

4. La prévention secondaire consiste à :

A. Vacciner la population

B. Dépister une maladie précocement

C. Rééduquer un patient

D. Éviter les complications en traitant tôt

5. Les déterminants de la santé liés au mode de vie comprennent :

A. L'environnement politique

B. Le comportement sexuel à risque

C. L'alimentation

D. La pollution atmosphérique

6. Selon la définition de l'OMS (1952), la santé publique vise à :

A. Assainir le milieu

B. Soigner les maladies graves uniquement

C. Enseigner les règles d'hygiène personnelle

D. Mettre en œuvre des mesures sociales pour maintenir la santé

7. Parmi les étapes de la démarche de santé publique, on retrouve :

A. L'analyse de la situation

B. La formulation d'objectifs

C. Le suivi et l'évaluation

D. L'administration de soins d'urgence

8. Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont socio-économiques.

A. Absence de troubles psychiques

B. L'existence d'un habitat salubre

C. Absence de troubles métaboliques

D. Environnement affectif satisfaisant

E. L'existence d'eau courante

F. L'absence de promiscuité

9. Les soins qui répondent aux besoins fondamentaux de l'être humain sont dits :

A. Supportables

B. Adaptés

C. Essentiels

Chapitre 2 — Système National de Santé et Politique Nationale de Santé

QCD — Questions à Choix Double (25)

1. Un système de santé est dit équitable lorsqu'il est accessible à tous dans les mêmes proportions sans discrimination.

2. Le système de santé ivoirien est sous forme pyramidale avec deux versants et trois niveaux.

3. Le système de santé colonial avait pour principal objectif de maintenir en bonne santé les colons et leurs familles.
4. L'une des insuffisances du système de santé ivoirien est son manque d'équité.
5. L'information sanitaire est l'un des piliers d'un système de santé.
6. Un bon système de santé doit être physiquement et financièrement accessible à tous.
7. Un système est un ensemble d'éléments reliés et interagissant qui forment un tout unifié, œuvrant vers des objectifs différents.
8. L'efficience est la capacité du système à faire le meilleur usage possible des ressources disponibles.
9. Un système de santé efficient est un système de santé qui produit les résultats attendus.
10. La pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire présente un versant prestataire et un versant stratégique.
11. La pyramide sanitaire du système de santé ivoirien comprend, de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central.
12. L'information sanitaire est l'une des fonctions du système de santé.
13. Le système de santé qui s'adapte constamment à l'évolution des besoins de la population est dit efficient.
14. L'acceptabilité d'un système de santé dépend de sa compatibilité avec la culture de la communauté.
15. Le Programme Élargi de Vaccination (PEV) fait partie des problèmes prioritaires du système de santé ivoirien.
16. Le renforcement des Soins de Santé Primaires (SSP) a été une priorité entre 1994 et 1997.
17. Le financement du système de santé de la Côte d'Ivoire est exclusivement assuré par les ONG partenaires.
18. Un système de santé planifiable permet de prévoir des solutions adaptées aux besoins sanitaires.
19. L'accessibilité physique à un système de santé implique uniquement la gratuité des soins.
20. Le système de santé est un ensemble d'éléments indépendants sans objectif commun.
21. Un système de santé est la totalité des organisations, institutions et ressources consacrées à la production d'actions visant principalement à améliorer, maintenir ou restaurer la santé.
22. Un système de santé efficient ou productif est un système de santé qui permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le plus faible coût possible.
23. L'accessibilité financière consiste à offrir les soins de santé aux populations à moindre coût.
24. L'étude de l'histoire du système de santé de la Côte d'Ivoire révèle trois grandes périodes.
25. La zone de silence sanitaire est une localité se trouvant à plus de 15 km de toute structure sanitaire.

QCM — Questions à Choix Multiples (21)

1. Des priorités ont été définies au cours de la période 1994-1997 dans le système de santé ivoirien. Elles portaient sur :
 - A. Le Programme Élargi de Vaccination (PEV)
 - B. La mise en place d'un système général d'assurance maladie
 - C. Le renforcement de la politique des Soins de Santé Primaires (SSP)
 - D. La naissance d'un véritable système de santé national et d'une politique de santé
 - E. Le renforcement du système de recouvrement des coûts des actes de santé
 - F. L'amélioration et le développement de structures de formation
2. Un système de santé a combien de fonctions ?
 - A. 6 fonctions

B. 2 fonctions

C. 4 fonctions

D. 8 fonctions

3. Le système de santé ivoirien a combien de piliers ?

A. Un système de santé a 2 piliers

B. Un système de santé a 1 pilier

C. Un système de santé a 4 piliers

D. Un système de santé a 6 piliers

4. Parmi ces propositions, laquelle ne fait pas partie des caractéristiques ou valeurs d'un bon système de santé ?

A. La globalité

B. L'accessibilité

C. Le leadership

D. L'équité

5. Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par :

A. Deux niveaux et trois versants

B. Trois niveaux et deux versants

C. Trois versants et trois niveaux

D. Deux niveaux et quatre versants

6. Au niveau primaire de la pyramide sanitaire du système de santé ivoirien, on trouve :

A. Les ESPC

B. Les EPHD

C. Les EPHR

7. Dans la période d'avant l'indépendance, laquelle des propositions suivantes fait partie des services offerts aux populations ?

A. Le confort et l'hygiène de l'habitat

B. L'hygiène en milieu scolaire

C. La prophylaxie des grandes endémies

D. L'hygiène au niveau des marchés — stratégie pré-avancée

8. L'organisation de l'hygiène collective consiste à déterminer les champs d'activités et les moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre l'insalubrité, le confort et l'hygiène de l'habitat, sauf une :

A. L'hygiène en milieu scolaire

B. L'hygiène au niveau des marchés

C. L'organisation de l'hygiène collective

D. L'assainissement du milieu

9. Les actions de prophylaxie des grandes endémies ont porté sur :

A. Le dépistage des cas de maladies

B. Les mesures préventives : vaccination, isolement, etc.

C. Le traitement des cas dépistés

D. Les stratégies fixes et mobiles

E. Toutes les réponses sont vraies

10. La période 1960-1980 : la prestation des services était organisée selon deux volets. Lesquels ?

- A. Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle la gratuité des soins
 - B. Un volet orienté sur la promotion de la santé
 - C. Un volet préventif basé sur une assistance médicale visant la lutte contre les grandes endémies (pian, trypanosomiase, lèpre, onchocercose, etc.)
11. Les bases de secteur de santé rurale ont été remplacées par les districts sanitaires en :
- A. 1996
 - B. 1994
 - C. 1991
12. L'efficacité est la capacité du système à :
- A. Offrir la qualité des prestations et l'obtention des résultats escomptés
 - B. Obtenir les meilleurs résultats possibles pour le plus faible coût possible
 - C. Faire le meilleur usage possible des ressources disponibles
 - D. Répondre effectivement aux besoins de la population
13. Les ressources humaines pour la santé comprennent :
- A. Les agents de santé communautaire
 - B. Les travailleurs cliniques
 - C. Les gestionnaires administratifs non médicaux
 - D. Les promoteurs immobiliers hospitaliers
14. En 1960, la capacité hospitalière en Côte d'Ivoire comprenait :
- A. L'hôpital central du Plateau
 - B. 3 CHU
 - C. Un dispensaire de 23 lits à Grand-Bassam
 - D. 14 centres de santé
15. Les objectifs fondamentaux d'un système de santé sont :
- A. Promouvoir la santé
 - B. Préserver les traditions locales
 - C. Prévenir les maladies
 - D. Restaurer la santé
16. Un système de santé est dit acceptable lorsqu'il :
- A. Correspond aux normes internationales
 - B. Est conforme aux attentes culturelles des populations
 - C. Repose uniquement sur des pratiques modernes
 - D. Est compatible avec les ressources de la communauté
17. Cocher les deux formes d'accessibilité dans le système de santé :
- A. Accessibilité géographique
 - B. Accessibilité médicale
 - C. Accessibilité financière
 - D. Accessibilité socio-culturelle
18. Parmi les propositions suivantes, identifier toutes celles qui définissent au mieux la caractéristique de liberté dans un système de santé :
- A. C'est lorsque le système donne la liberté au malade de pouvoir s'adresser à la structure et à l'agent de santé de son choix

- B. C'est lorsque le système permet à l'agent de santé d'avoir une liberté de prescription
- C. C'est lorsque le système donne la liberté au malade de pouvoir s'adresser à l'agent de santé de son choix
- D. Toutes les propositions sont bonnes

19. Le système de santé ivoirien repose sur :

- A. Trois piliers
- B. Quatre piliers
- C. Cinq piliers
- D. Six piliers

20. Un système de santé est :

- A. Un ensemble des moyens organisationnels et matériels pour atteindre le but de la politique de santé
- B. Un ensemble des moyens structurels et stratégiques pour atteindre le but de la politique de santé
- C. Un ensemble des moyens organisationnels et stratégiques pour atteindre le but de la politique de santé
- D. Un ensemble des moyens structurels et matériels pour atteindre le but de la politique de santé

21. La pyramide sanitaire ivoirienne se caractérise par :

- A. Deux versants et trois niveaux
- B. Deux niveaux et trois versants
- C. Trois niveaux et trois versants
- D. Deux niveaux et deux versants

Chapitre 3 — Programme Élargi de Vaccination (PEV)

QCD — Questions à Choix Double (19)

1. Le tuberculeux peut réaliser le traitement DOTS pendant qu'il est seul dans son cadre de vie.
2. Entre deux doses d'un vaccin à contacts multiples, on peut observer un intervalle de plus de 4 semaines.
3. Le vaccin contre le papillomavirus s'administre dans la région inférieure du bras gauche en intramusculaire.
4. La coqueluche, l'hépatite C, la rubéole et la fièvre jaune font partie des maladies cibles du Programme Élargi de Vaccination de Côte d'Ivoire.
5. La chaîne de froid est un dispositif continu de conservation des vaccins à une température convenable entre 2 et 8°C, depuis l'usine de fabrication jusqu'au bras de la personne vaccinée.
6. Une association vaccinale successive est l'administration de plusieurs antigènes à un organisme le même jour.
7. Les Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT) sont situés au niveau périphérique du PNLT.
8. Le vaccin ROTARIX s'administre à la 6ème, 10ème et 14ème semaine de naissance.
9. Un enfant qui présente les signes du SIDA peut recevoir le vaccin VPI.
10. Un enfant qui présente les signes du SIDA peut recevoir le vaccin VAA.
11. À 10 semaines, un enfant peut recevoir les antigènes suivants : (DTChepBHib)-2 + VPO-2 + VPI-2 + Rota-2.
12. Une femme enceinte qui reçoit deux doses de Td est protégée durant trois ans contre le tétanos.
13. Une association combinée est un ensemble d'antigènes associés dans le même flacon depuis le laboratoire de synthèse du vaccin.
14. Le vaccin Penta permet de prévenir la survenue de la diphtérie chez les nourrissons.

15. La prématurité est une contre-indication du BCG.

16. En Côte d'Ivoire, pour une population totale de 3000 habitants en 2023, le nombre d'enfants de 0 à 11 mois et celui des femmes enceintes sont respectivement de 105 et 150.

17. En matière de vaccination, l'intervalle minimum entre deux doses est de 4 semaines.

18. On peut administrer le VPI à un enfant âgé de 10 semaines.

19. La proportion des jeunes filles de 9 ans est de 1,86 % de la population totale.

QCM — Questions à Choix Multiples (22)

1. Dans le principe de rattrapage vaccinal, lorsqu'un enfant n'a pas atteint 9 mois, il faut lui administrer en priorité le :

- A. BCG
- B. Penta
- C. VPO

2. Dans le principe de rattrapage vaccinal, lorsqu'un enfant a atteint 9 mois, il faut lui administrer en priorité le :

- A. RR
- B. BCG
- C. Penta

3. Dans le cadre d'une association vaccinale combinée, les différents antigènes sont administrés le même jour. Comment ?

- A. Au même point d'injection et par la même voie d'injection
- B. Au même point d'injection et par des voies d'injection différentes
- C. Par la même voie d'injection et à des points d'injection différents

4. Parmi les populations cibles suivantes, choisir les trois qui sont les cibles de rattrapage du PEV Ivoirien :

- A. Les jeunes filles de 9 ans pour la vaccination contre le HPV
- B. Les enfants de 12 à 23 mois pour tous les antigènes des enfants
- C. Les jeunes filles de 10 à 14 ans pour la vaccination contre le HPV
- D. Les femmes enceintes pour le Td
- E. Les femmes 3 ans après l'accouchement pour le Td
- F. Les enfants de 0 à 11 mois pour tous les antigènes des enfants

5. Parmi les antigènes suivants, indiquez celui qui est inactivé.

- A. ROTARIX
- B. HPV
- C. VAA

6. Parmi les antigènes suivants, indiquez celui qui est administré en intradermique.

- A. PCV13
- B. VPI
- C. BCG

7. Parmi les propositions suivantes, choisir les deux principes de priorité de rattrapage d'une série de vaccination chez un enfant mal ou non vacciné.

- A. Pour un enfant ayant atteint 9 mois, il faut lui administrer le RR en priorité
- B. Pour un enfant n'ayant pas atteint 9 mois, il faut lui administrer le BCG en priorité
- C. Pour un enfant n'ayant pas atteint 9 mois, il faut lui administrer le Penta en priorité

- D. Pour un enfant ayant atteint 9 mois, il faut lui administrer le VAA en priorité
- E. Pour un enfant n'ayant pas atteint 9 mois, il faut lui administrer le RR en priorité
8. Le PEV Ivoirien a pour objectifs d'assurer la protection par la vaccination des :
- A. Enfants de 0 à 11 mois contre 14 (ou 15) maladies
 - B. Enfants de 0 à 23 mois contre 14 (ou 15) maladies
 - C. Femmes en âge de reproduction contre 02 maladies
 - D. Jeunes filles de 9 à 14 ans contre 01 maladie
 - E. Femmes enceintes contre 02 maladies
 - F. Jeunes filles de 9 ans contre 01 maladie
9. Le vaccin Penta est composé des antigènes suivants :
- A. Diphtérie – Haemophilus influenzae de type C – Coqueluche – Tétanos – Hépatite B
 - B. Hépatite B – Diphtérie – Haemophilus influenzae de type B – Tétanos – Coqueluche
 - C. Diphtérie – Tétanos – Coqueluche – Men A – Haemophilus influenzae de type B
 - D. Diphtérie – Typhoïde – Coqueluche – Hépatite B – Haemophilus influenzae de type B
10. Le vaccin contre la diarrhée à rotavirus est un vaccin :
- A. Inactivé
 - B. Vivant
 - C. Vivant atténué
11. La voie d'administration du vaccin Polio Inactivé (VPI) est :
- A. Orale
 - B. Intramusculaire
 - C. Intradermique
12. Un enfant qui présente des syndromes d'immunodéficience congénitale doit recevoir :
- A. Le VPI plutôt que le VPO
 - B. Le VPO plutôt que le VPI
 - C. Le VPI et le VPO
13. PEV Ivoirien a pour objectifs de contribuer à :
- A. L'éradication de la poliomyélite
 - B. L'élimination du tétanos maternel et néonatal et de la rougeole
 - C. Au contrôle de la fièvre jaune
14. Parmi les antigènes suivants, indiquez celui qui est vivant atténué :
- A. Td
 - B. RR
 - C. VPI
15. Parmi les antigènes suivants, indiquez les deux qui sont administrés en sous-cutanée :
- A. PCV13
 - B. RR
 - C. BCG
 - D. VAA
 - E. VPO
 - F. ROTARIX

16. Quelles sont les populations cibles du PEV Ivoirien ?

- A. Les jeunes filles de 9 ans
- B. Les enfants de 12 à 23 mois
- C. Les femmes en âge de reproduction
- D. Les jeunes filles de 10 à 14 ans
- E. Les femmes enceintes
- F. Les enfants de 0 à 23 mois

17. Parmi les vaccins ci-dessous, choisir les deux qu'il ne faut pas administrer chez un nourrisson en cas de signes ou symptômes avérés de SIDA :

- A. Le BCG et le vaccin anti-amaril
- B. Le vaccin Penta et le vaccin Rotarix
- C. Le vaccin anti-amaril et le vaccin RR

18. Combien de doses de l'antigène diphtérie reçoit un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné ?

- A. 1 dose
- B. 3 doses
- C. 4 doses

19. Cochez le nombre d'antigènes et de doses qu'un enfant doit recevoir avant son premier anniversaire :

- A. 19 doses de 14 vaccins
- B. 24 doses de 15 vaccins
- C. 16 doses de 12 vaccins
- D. 15 doses de 15 vaccins

20. Quel est l'ordre normal d'administration de ces groupes d'antigènes conformément au calendrier de vaccination du PEV Ivoirien ? (1. Penta3+VPO-3+PCV13-3+VPI ; 2. Penta2+VPO-2+PCV13-2+Rota2 ; 3. VPO-0+BCG+DTG-HepB ; 4. Penta1+VPO-1+PCV13-1+Rota1 ; 5. RR+VAA+MenA)

- A. (1,2,3,4,5)
- B. (3,4,1,2,5)
- C. (4,3,2,1,5)
- D. (3,4,2,1,5)

21. Les jeunes filles de 9 ans représentent, dans l'activité de vaccination de routine :

- A. 4 % de la population totale
- B. 45 % de la population totale
- C. 20 % de la population totale
- D. 1,86 % de la population totale

22. Parmi les définitions suivantes, laquelle correspond à la définition de la stratégie avancée ?

- A. L'équipe mobile du district se déplace vers les populations des localités situées au-delà de 15 km des centres de santé pour administrer les actes de santé
- B. Le personnel de santé reste au centre de santé et reçoit les populations des localités situées dans un rayon de moins de 5 km autour dudit centre
- C. Le personnel de santé quitte le centre de santé et va vers les populations des localités situées entre 5 km et 15 km autour dudit centre

Étude de cas 1 — Aire sanitaire de Djatokro

L'aire sanitaire de Djatokro, que vous gérez en tant qu'Infirmier, Sage-Femme ou Maïeuticien,

compte six (6) localités avec les données 2024 suivantes :

Localité

Population totale (hbts)

Distance A/R au centre de santé

Yapikoi

9 000

29,8 Km

Palédouho

399

44 Km

Koboko

4 999

34 Km

Djatokro

2 000

0 Km

Koffikro

3 600

11 Km

Binibahango

499

14 Km

1. Parmi les localités de cette aire sanitaire, choisir celle(s) concernée(s) par la stratégie fixe de vaccination du PEV Ivoirien :

A. Koboko

B. Koffikro

C. Palédouho

D. Djatokro

E. Binibahango

F. Yapikoi

2. Parmi les localités de cette aire sanitaire, choisir celle(s) concernée(s) par la stratégie avancée de vaccination du PEV Ivoirien :

A. Djatokro

B. Binibahango

C. Koboko

D. Koffikro

E. Palédouho

F. Yapikoi

3. Parmi les localités de cette aire sanitaire, choisir celle(s) concernée(s) par la stratégie mobile de vaccination du PEV Ivoirien :

A. Djatokro

B. Binibahango

- C. Koboko
- D. Koffikro
- E. Palédouho
- F. Yapikoi

Étude de cas 2 — CSR Kakoukro Limite (District sanitaire d'Adiaké)

Après l'obtention du diplôme d'État d'infirmier(ère)/sage-femme avec brio, vous êtes affecté(e) au Centre de Santé Rural de Kakoukro Limite. Dès votre prise de service, le médecin-chef du district vous demande de calculer certaines populations cibles de votre aire sanitaire à partir du tableau ci-dessous. La population totale actualisée de l'année 2022 est de 25 000 habitants, répartie comme suit :

Centre de santé / Village

Population

Distance par rapport au centre de santé

Village A (centre de santé)

7 500 hbts

0 Km

Village B

4 000 hbts

3 Km

Village C

3 500 hbts

4 Km

Village D

6 500 hbts

6 Km

Village E

3 500 hbts

15 Km

1. Quelle est l'estimation de la population cible des jeunes filles de 9 ans du bassin de desserte du CSR Kakoukro Limite ?

- A. 250 jeunes filles
- B. 338 jeunes filles
- C. 465 jeunes filles
- D. 525 jeunes filles

2. La quantité théorique mensuelle du vaccin contre le papillomavirus humain du bassin de desserte du CSR Kakoukro Limite est (en supposant que toutes les jeunes filles sont séronégatives) :

- A. 20 doses
- B. 38 doses
- C. 39 doses
- D. 41 doses

3. Sachant que le nombre d'enfants de 0 à 11 mois représente 3,5 % de la population totale, déterminer le nombre d'enfants de 0 à 11 mois vivant dans un rayon de moins de 5 Km de l'aire de santé pour l'année 2022 :

- A. 600 enfants de 0 à 11 mois

B. 750 enfants de 0 à 11 mois

C. 525 enfants de 0 à 11 mois

D. 1000 enfants de 0 à 11 mois

4. Le nombre d'enfants de 1 à 4 ans vivant dans un rayon de 5 à 15 Km de l'aire de santé pour l'année 2022 est :

A. 1000 enfants de 1 à 4 ans

B. 4330 enfants de 1 à 4 ans

C. 1732 enfants de 1 à 4 ans

D. 2000 enfants de 1 à 4 ans

5. Le nombre d'enfants de 0 à 5 ans vivant dans un rayon de moins de 5 Km de l'aire de santé pour l'année 2022 est :

A. 750 enfants de 0 à 5 ans

B. 2598 enfants de 0 à 5 ans

C. 3000 enfants de 0 à 5 ans

D. 600 enfants de 0 à 5 ans

6. Sachant que le nombre de naissances attendues représente 4,7 % de la population totale, déterminer le nombre de naissances attendues dans l'aire de santé pour l'année 2022 :

A. 875 naissances attendues

B. 1000 naissances attendues

C. 1175 naissances attendues

D. 525 naissances attendues

7. Le nombre de femmes enceintes vivant dans un rayon de 5 à 15 Km de l'aire de santé pour l'année 2022 est :

A. 3000 femmes

B. 2000 femmes

C. 5000 femmes

D. 500 femmes

8. Le nombre de Femmes en Âge de Reproduction (FAR) vivant dans un rayon de 5 à 15 Km de l'aire de santé pour l'année 2022 est :

A. 2000 femmes

B. 1250 femmes

C. 500 femmes

D. 750 femmes

Chapitre 4 — Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT)

QCD — Questions à Choix Double (3)

1. Les Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT) sont situés au niveau périphérique du PNLT.

2. Les centres antituberculeux sont situés au niveau intermédiaire du versant administratif du PNLT.

3. Les laboratoires régionaux du PNLT sont installés dans les Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT) des districts de santé.

QCM — Questions à Choix Multiples (3)

1. Parmi les objectifs de lutte antituberculeuse suivants, indiquez les trois qui relèvent du niveau central de la pyramide sanitaire.

A. Taux de succès thérapeutique des nouveaux cas et rechutes de tuberculose toute forme confondue supérieur ou égal à 89 %

- B. Taux de couverture du TDO à 100 % sur l'ensemble du territoire national
- C. Taux de décès inférieur ou égal à 07 %
- D. Impliquer la communauté dans les activités de lutte contre la tuberculose
- E. Taux de perdus de vue inférieur ou égal à 02 %
- F. Taux de dépistage d'au moins 70 % des TPM+

2. Parmi les objectifs de lutte antituberculeuse suivants, indiquez les trois qui relèvent du niveau périphérique de la pyramide sanitaire.

- A. Taux de succès thérapeutique des nouveaux cas et rechutes de tuberculose toute forme confondue supérieur ou égal à 89 %
- B. Taux de couverture du TDO à 100 % sur l'ensemble du territoire national
- C. Taux de décès inférieur ou égal à 07 %
- D. Impliquer la communauté dans les activités de lutte contre la tuberculose
- E. Taux de perdus de vue inférieur ou égal à 02 %
- F. Dépistage d'au moins 70 % des TPM+

3. L'organisation et le fonctionnement du Programme National de Lutte contre la Tuberculose se font autour de :

- A. Quatre versants
- B. Trois versants
- C. Deux versants

Chapitre 5 — Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)

Aucune question spécifique au PNLP n'a été identifiée dans les sujets fournis (le paludisme n'apparaît que comme exemple ponctuel dans des questions sur les vecteurs ou l'hygiène — voir Santé Communautaire, chapitre 3).

Chapitre 6 — Généralités sur l'Épidémiologie

QCD — Questions à Choix Double (25)

1. Dans l'approche épidémiologique, la thérapie repose sur le contrôle, l'éradication, l'élimination et la maîtrise de la maladie.
2. L'endémie est un phénomène de masse illimité dans le temps mais limité dans l'espace.
3. Une endémie est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois.
4. Une endémie est une maladie persistante dans une population, limitée dans le temps.
5. La pandémie est un phénomène limité dans le temps mais illimité dans l'espace.
6. La pandémie est limitée dans le temps et dans l'espace.
7. La létalité permet d'apprécier l'ampleur d'une maladie.
8. Le taux brut de natalité est un indicateur à tendance négative.
9. L'épidémiologie descriptive cherche à répondre à la question : « Pourquoi ? ».
10. L'épidémiologie est une discipline clinique orientée vers le diagnostic individuel.
11. L'épidémiologie contribue à la cartographie des maladies émergentes.
12. L'approche clinique vise à diagnostiquer la maladie chez un sujet donné.
13. Une proportion est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur.
14. Le taux est le rapport pour lequel le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur.
15. La démarche épidémiologique commence par la collecte des données.
16. L'épidémiologie permet de mesurer l'état de santé d'une population.
17. L'un des buts de l'épidémiologie est de mesurer les risques individuels et collectifs.

18. L'épidémiologie descriptive fait partie de l'épidémiologie d'observation.
19. L'approche épidémiologique a pour objet le malade.
20. L'approche épidémiologique a pour objet la population.
21. L'approche clinique recherche les causes d'apparition de la maladie chez le sujet.
22. L'épidémiologie est la discipline scientifique qui étudie la distribution et les déterminants des états de santé et de maladie dans la population, ainsi que les influences qui déterminent cette distribution (OMS, 1968).
23. La rougeole est un phénomène de masse parce qu'elle sévit à l'état endémique.
24. L'épidémiologie analytique répond-elle à la question « Combien ? ».
25. L'axe d'intervention évalue le bien-fondé ou non des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population.

QCM — Questions à Choix Multiples (16)

1. L'endémie est :
 - A. Un phénomène de masse limité dans le temps et dans l'espace
 - B. Un phénomène de masse illimité dans le temps mais limité dans l'espace
 - C. Un phénomène de masse illimité dans l'espace mais limité dans le temps
 - D. Un phénomène de masse illimité dans le temps et dans l'espace
2. Une épidémie est un phénomène (choisir les deux bonnes réponses) :
 - A. Limité dans le temps
 - B. Limité dans l'espace
 - C. Illimité dans le temps
 - D. Illimité dans l'espace
3. Une pandémie est un phénomène (choisir les deux bonnes réponses) :
 - A. Limité dans le temps
 - B. Limité dans l'espace
 - C. Illimité dans le temps
 - D. Illimité dans l'espace
4. Une endémie est un phénomène (choisir les deux bonnes réponses) :
 - A. Limité dans le temps
 - B. Limité dans l'espace
 - C. Illimité dans le temps
 - D. Illimité dans l'espace
5. Les phénomènes de masse comprennent :
 - A. L'épidémie
 - B. La pandémie
 - C. L'endémie
 - D. La zoonose
6. Les caractéristiques d'une épidémie sont :
 - A. Limitée dans l'espace
 - B. Illimitée dans le temps
 - C. Inattendue
 - D. Soudaine

7. La différence entre fréquence absolue et fréquence relative est que :

- A. La fréquence relative exprime un rapport
- B. La fréquence absolue est un pourcentage
- C. La fréquence relative met en lien deux quantités
- D. La fréquence absolue est un simple comptage

8. Le rapport peut être :

- A. Un taux
- B. Une fréquence absolue
- C. Un indice
- D. Une proportion

9. Un indice est utilisé quand :

- A. Le numérateur est inclus dans le dénominateur
- B. Le dénominateur est incertain
- C. Le rapport concerne deux événements distincts
- D. Le calcul est impossible

10. Les indicateurs de santé à tendance négative sont :

- A. Taux brut de natalité
- B. Indicateurs de mortalité
- C. Indicateurs de morbidité
- D. Accroissement naturel

11. L'approche épidémiologique se différencie de l'approche clinique par :

- A. Son objet d'étude
- B. La finalité de l'analyse
- C. Son intérêt pour l'individu malade uniquement
- D. Sa visée populationnelle

12. Les buts de l'épidémiologie incluent :

- A. Guérir les patients
- B. Mesurer les risques de santé
- C. Comprendre l'état de santé d'une population
- D. Évaluer les méthodes d'intervention

13. Les axes en épidémiologie sont :

- A. Descriptif
- B. Interactif
- C. Analytique
- D. Évaluatif

14. Quels sont les différents axes de l'épidémiologie ?

- A. L'axe problématique
- B. L'axe analytique
- C. L'axe d'intervention
- D. L'axe évaluatif
- E. L'axe descriptif

15. Parmi les propositions ci-dessous, cocher celle qui correspond au rôle de l'axe analytique en épidémiologie :

- A. Étudie la fréquence de la répartition de la maladie ou de la santé dans le temps, dans l'espace et en fonction des caractéristiques de la population
- B. Évalue le bien-fondé ou non des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population
- C. Recherche les causes d'apparition de la maladie, du phénomène de santé, ou les lie à des facteurs de risque

16. En épidémiologie descriptive, les paramètres étudiés sont :

- A. Où ?
- B. Quand ?
- C. Pourquoi ?
- D. Qui ?

Chapitre 7 — Surveillance Épidémiologique

QCD — Questions à Choix Double (3)

- 1. Le seuil épidémique correspond à la valeur normale attendue des cas.
- 2. Les cas suspects, probables et confirmés font partie de la classification des cas en épidémiologie.
- 3. Un cas confirmé de fièvre jaune au niveau communautaire est toute personne présentant un jaunissement soudain de la peau de plus de deux semaines, avec obligatoirement une forte chaleur corporelle.

QCM — Questions à Choix Multiples (2)

- 1. Un seuil d'alerte est déclenché lorsque :
 - A. L'épidémie est terminée
 - B. Un cas suspect est notifié
 - C. Une flambée inhabituelle est observée
 - D. Les cas dépassent les attentes habituelles
- 2. La riposte épidémique comprend :
 - A. Campagne d'IEC/CCC
 - B. Notification aux autorités
 - C. Prise en charge des cas
 - D. Fermeture automatique des centres de santé

PARTIE II — SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Chapitre 1 — Étude du Milieu ou Monographie

QCD — Questions à Choix Double (11)

- 1. Pendant l'étude du milieu, le personnel de santé doit couvrir les possibilités d'amélioration de la vie de la population.
- 2. Pendant l'étude du milieu, le personnel de santé doit amener les populations à se comprendre elles-mêmes.
- 3. Toute action sanitaire et sociale dans un milieu de vie ne nécessite pas la rencontre des hommes dans leur milieu de vie.
- 4. La recherche des facteurs du milieu pouvant influencer positivement ou négativement leur existence, et la compréhension de ces facteurs, font partie des préalables à toute action sanitaire et sociale dans un milieu de vie.
- 5. La cartographie du centre constitue la carte d'identité de la structure sanitaire.
- 6. Les facteurs physiologiques constituent le fonctionnement correct de certains organes.

7. Un patrimoine génétique correct et complet est un facteur physiologique favorisant la maladie.
8. L'âge et les soucis sont des facteurs biologiques favorisant la maladie.
9. Les facteurs favorisant la maladie sont des facteurs de risque ou de nuisance provenant du milieu interne de l'individu.
10. La monographie est l'étude de la connaissance d'une région, d'un milieu culturel donné, dans toutes ses dimensions physiques, sociales, économiques, culturelles et spirituelles.
11. Une entité constituée tout au plus de deux personnes est un groupe.

QCM — Questions à Choix Multiples (9)

1. Dans le cadre de l'étude du milieu, « Observer » et « Dialoguer » consistent à (cochez les deux bonnes réponses) :
 - A. Établir les priorités permettant de définir les objectifs d'action
 - B. Interroger les malades sur leur état de santé
 - C. Regarder uniquement les informations enregistrées dans le registre de consultation
 - D. Exploiter les informations données uniquement par le responsable du district sanitaire
 - E. Regarder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu
 - F. Organiser uniquement des rencontres avec le personnel de santé
2. Un des éléments dans la liste ci-après ne fait pas partie de la définition de l'étude du milieu de l'UNICEF (1992). Lequel ?
 - A. C'est la connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent
 - B. C'est la connaissance des problèmes et des moyens de résolution de ces problèmes qui existent dans ce milieu
 - C. C'est la connaissance des critères de sélection des populations à l'étude
 - D. C'est la connaissance des populations cibles
3. Un élément dans la liste ci-après ne fait pas partie des groupes de facteurs du milieu pouvant agir sur la santé. Lequel ?
 - A. Facteurs du milieu favorisant la santé
 - B. Facteurs du milieu déterminant la santé
 - C. Facteurs du milieu favorisant la maladie
 - D. Facteurs du milieu déterminant la maladie
4. Les informations relatives à l'agriculture et à l'alimentation permettent à l'agent de santé de :
 - A. Planifier les activités promotionnelles, préventives et curatives dans les écoles
 - B. Connaître la communauté et son organisation sociale
 - C. Répertorier les centres de soins, organiser la supervision des agents de santé des structures privées et faire la surveillance intégrée des maladies à potentiel épidémique en vue de mieux organiser la riposte
 - D. Connaître le pouvoir d'achat des populations, orienter les messages éducatifs dans le domaine de l'alimentation
5. Les informations relatives à l'éducation et à la formation professionnelle permettent à l'agent de santé de :
 - A. Planifier les activités promotionnelles, préventives et curatives dans les écoles
 - B. Connaître la communauté et son organisation sociale
 - C. Répertorier les centres de soins et organiser la supervision des agents de santé des structures privées
 - D. Connaître le pouvoir d'achat des populations, orienter les messages éducatifs dans le domaine de l'alimentation

6. Les informations relatives à la population permettent à l'agent de santé de :
- A. Planifier les activités promotionnelles, préventives et curatives dans les écoles
 - B. Connaître la communauté et son organisation sociale
 - C. Connaître le dénominateur, c'est-à-dire les populations cibles
 - D. Établir le lien entre les maladies et les eaux de surface
7. Deux des données ci-dessous entrent dans l'élaboration d'un document monographique. Lesquelles ?
- A. Les données relatives à l'agrobiologie
 - B. Les données relatives à l'éducation
 - C. Les données relatives à l'agronomie
 - D. Les données relatives à l'agrochimie
 - E. Les données relatives à la communauté
8. Les données sanitaires sont en rapport avec (cochez les deux bonnes réponses) :
- A. Le nombre de techniciens supérieurs de santé
 - B. Le nombre de cliniques médicales
 - C. La maladie la plus rencontrée de la localité
 - D. Le nombre de structures publiques
 - E. Le nombre de techniciens de surface
9. Parmi les différentes données relatives à la monographie, choisir les deux relatives aux ressources humaines :
- A. Le nombre de comités d'hygiène et le nom des présidents
 - B. Le nombre de structures sanitaires privées et publiques
 - C. Le nombre d'infirmiers et de sages-femmes spécialistes
 - D. Le nombre de cliniques médicales et infirmeries privées
 - E. Le nombre d'infirmiers et de sages-femmes diplômés d'État

Chapitre 2 — Hygiène et Assainissement du Milieu

QCD — Questions à Choix Double (27)

- 1. L'ébullition a pour inconvénient de faire perdre à l'eau les gaz dissous.
- 2. L'évacuation insalubre des fèces et des urines conduit à la contamination des sols et des sources d'approvisionnement en eau.
- 3. La fosse septique permet d'éviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.
- 4. Prévoir entre la latrine et les puits une distance d'au moins 1500 centimètres.
- 5. Le fond de la latrine doit être situé au moins à 1,5 mètre en dessous de la nappe aquifère.
- 6. Une eau potable minéralisée est riche en ions chlore et sulfate.
- 7. En cas de terrain en pente, le puits doit être placé en aval des sources de contamination.
- 8. La latrine doit être placée en aval d'un puits.
- 9. Les qualités requises pour qu'une eau soit considérée potable sont à la fois physiques, chimiques et bactériologiques.
- 10. Une décharge commune doit être située au moins à 20 mètres de tout habitat.
- 11. Le compostage consiste à mettre les déchets végétaux dans un trou, à les recouvrir de 2 à 3 cm de terre, puis à y mettre le feu.
- 12. Un cabinet à fosse est un dispositif d'évacuation des excréta creusé à la main.
- 13. Les eaux de surface sont constituées par l'eau de pluie récoltée, l'eau des lacs, des lagunes, des

mares, des mers et des sources.

14. Les eaux souterraines sont constituées par l'eau de pluie récoltée, l'eau des lacs et des lagunes.

15. On distingue deux types d'eau : les eaux souterraines et les eaux de surface.

16. Les eaux de surface émergent sous forme de sources.

17. Les activités d'hygiène et d'assainissement sont un ensemble d'actions de propreté menées au sein d'une population pour préserver sa santé.

18. L'assainissement est l'ensemble des moyens collectifs visant à préserver la santé et la propreté du corps.

19. Les pollutions diffuses sont causées par les déchets des usines, les eaux de lavage, de refroidissement et de graissage.

20. Les pollutions industrielles sont provoquées par les détergents, les hydrocarbures et les huiles de vidange.

21. Les pollutions collectives proviennent des déchets des usines, des eaux de lavage, de refroidissement et de graissage.

22. La carie dentaire est due à un manque de fluor dans l'eau.

23. Le choléra est une maladie virale.

24. Dans le système d'évacuation des excréta sans entraînement de matières fécales, les excréta sont directement déposés dans le sol sec ou humide.

25. Il existe deux types de stockage des ordures : le stockage familial et le stockage public.

26. L'une des précautions pour la construction d'un puits traditionnel est de le situer à moins de 15 mètres de toute source de contamination.

27. L'absence d'humidité dans le logement est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins physiologiques.

QCM — Questions à Choix Multiples (18)

1. La turbidité de l'eau peut être corrigée par (cochez trois bonnes réponses) :

A. La décantation

B. La chloration

C. L'ionisation

D. La filtration

E. L'ébullition

F. La sédimentation

2. Parmi les propositions suivantes, choisir les trois actions qui permettent de corriger la turbidité de l'eau :

A. La décantation

B. L'usage du charbon activé en poudre

C. La filtration

D. La sédimentation

E. La chloration

F. L'ébullition

3. Parmi les propositions suivantes, choisir la quantité d'eau de javel qu'il faut pour purifier 10 litres d'eau trouble :

A. 3 gouttes

B. 6 gouttes

C. 4 gouttes

4. La correction des défauts bactériologiques de l'eau à l'aide de l'eau de javel se fait dans les proportions suivantes (choisir les deux bonnes réponses) :

- A. Eau claire : 6 gouttes pour 10 litres d'eau
- B. Eau claire : 2 gouttes pour 10 litres d'eau
- C. Eau claire : 3 gouttes pour 10 litres d'eau
- D. Eau trouble : 8 gouttes pour 10 litres
- E. Eau trouble : 6 gouttes pour 10 litres
- F. Eau trouble : 5 gouttes pour 10 litres

5. L'ébullition, méthode de correction des défauts bactériologiques de l'eau, consiste à bouillir l'eau et à la laisser reposer pendant :

- A. 10 à 15 minutes
- B. 5 à 10 minutes
- C. 20 à 35 minutes

6. Quels sont les critères du choix d'une source d'eau ?

- A. La salubrité
- B. Le coût
- C. La puissance
- D. La régularité
- E. Le débit

7. Quelles sont les qualités d'une eau potable ?

- A. Physique
- B. Chimique
- C. Bactériologique
- D. Électronique

8. Quels sont les facteurs de l'eau qui peuvent produire des maladies ?

- A. Maladie liée au développement de vecteurs dans l'eau
- B. La présence de germes
- C. La couleur de l'eau
- D. La qualité chimique de l'eau

9. Les maladies liées à la qualité chimique de l'eau sont :

- A. La carie dentaire
- B. La fièvre jaune
- C. Le saturnisme

10. Les qualités physiques d'une eau potable sont :

- A. Trouble
- B. Minéralisée
- C. Inodore
- D. Ne pas avoir une saveur désagréable
- E. Iodée

11. Quels sont les objectifs de l'hygiène du milieu ? (cocher la mauvaise réponse)

- A. Prévenir la morbidité prématurée
- B. Assurer le confort

C. Assurer le bon rendement de l'organisation humaine

D. Prévenir les maladies et les traumatismes

E. Prévenir la mortalité prématurée

12. Parmi les températures suivantes, choisir celle qui assure le confort d'une chambre :

A. 26 à 28°C

B. 21 à 22°C

C. 27 à 28°C

13. Deux méthodes sont utilisées dans le processus de traitement des ordures ménagères. Lesquelles ?

A. Le stockage

B. Le ramassage

C. Le compostage

D. L'incinération

14. Parmi les propositions suivantes, choisir les deux phases qui interviennent dans le processus d'évacuation des ordures ménagères :

A. L'incinération

B. Le ramassage

C. Le traitement

D. Le compostage

E. Le stockage

15. Deux clés pour une alimentation plus sûre sont :

A. Prendre l'habitude de la propreté

B. Bien cuire les aliments

C. Assembler les aliments crus et cuits

D. Garder la nourriture à température ambiante

16. Les maladies liées au manque d'hygiène alimentaire sont (cochez les deux bonnes réponses) :

A. Paludisme

B. La fièvre typhoïde

C. Choléra

D. Hépatite B

E. Marasme

17. Les deux habitudes de propreté sont :

A. Tenir les insectes, les rongeurs et les animaux à l'écart des aliments et de la cuisine

B. Éviter le contact entre les aliments crus et les aliments prêts à la consommation

C. Conserver la nourriture dans des récipients ouverts

D. Faire bien réchauffer les aliments déjà cuits

E. Ne pas laisser des aliments cuits plus de deux heures à température ambiante

18. Garder la nourriture à température sûre, c'est (cochez les deux bonnes réponses) :

A. Laisser des aliments cuits plus de deux heures à température ambiante

B. Réfrigérer rapidement tous les aliments cuits et les denrées périssables (de préférence à moins de 5°C)

C. Ne pas conserver la nourriture trop longtemps, même au réfrigérateur, pendant plus de trois jours

D. Choisir des aliments frais et sains

E. Utiliser des aliments au-delà de la date de péremption

Chapitre 3 — Lutte contre les Vecteurs, Rongeurs et Nuisances Sonores

QCD — Questions à Choix Double (4)

1. Déposer des grillages aux portes et fenêtres de tous les locaux d'habitation est une méthode de lutte contre les larves de moustiques.

2. Éliminer ou réduire les gîtes de reproduction par le désherbage des pourtours des concessions est une méthode de lutte contre les moustiques adultes.

3. Le paludisme est une maladie liée au développement de vecteurs dans l'eau.

4. Les méthodes de lutte défensive reposent sur la disparition des ordures ménagères par leur ramassage soigné, quotidien, et leur destruction.

QCM — Questions à Choix Multiples (4)

1. Les méthodes de lutte contre les rongeurs sont :

A. Les méthodes de lutte dépressive

B. Les méthodes de lutte défensive

C. Les méthodes de lutte offensive

2. Parmi les propositions suivantes, choisir les deux modes de transmission de la maladie par les vecteurs :

A. Transmission biologique

B. Transmission mécanique

C. Transmission génétique

D. Transmission géologique

E. Transmission physiologique

3. Parmi les maladies suivantes, choisir celle liée au développement du vecteur dans l'eau :

A. Le choléra

B. La fièvre jaune

C. L'onchocercose

D. La rougeole

E. Le paludisme

4. L'emploi de germes microbiens mélangés à un appât est :

A. Une méthode de lutte biologique

B. Une méthode de lutte mécanique

C. Une méthode de lutte défensive

D. Une méthode de lutte offensive

Chapitre 4 — Soins de Santé Primaires (SSP)

QCD — Questions à Choix Double (26)

1. L'axe d'intervention évalue le bien-fondé ou non des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population.

2. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité indépendante du système national de santé.

3. Le niveau intermédiaire ou niveau secondaire est le niveau de mise en œuvre des activités de SSP.

4. La fourniture en médicaments essentiels est une composante curative des SSP.

5. L'un des objectifs généraux des SSP est de mettre en place un système de prestations sanitaires qui réponde de façon plus efficace aux besoins prioritaires de santé de la majorité de la population.

6. En Côte d'Ivoire, la politique de soins de santé primaires comprend deux composantes promotionnelles.
7. La participation active des populations aux activités des centres de santé est une recommandation de l'Initiative de Bamako.
8. En 1987, les États africains membres de l'Organisation Mondiale de la Santé se sont retrouvés dans la capitale zambienne (Lusaka) pour dégager trois niveaux d'application des Soins de Santé Primaires.
9. Les SSP se situent au niveau périphérique et au niveau intermédiaire du système national de santé.
10. La mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993.
11. Dans le domaine des soins de santé primaires, le niveau périphérique est le niveau d'appui ou de soutien au niveau secondaire.
12. En matière de soins de santé primaires, les soins accessibles sont des soins mis à la portée de tous, tant au plan géographique, social, financier que culturel.
13. L'objectif général des soins de santé primaires est de réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles par la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.
14. La vaccination contre les principales maladies infectieuses est une composante promotionnelle des SSP.
15. L'Initiative de Bamako a introduit un système de gestion communautaire et de recouvrement des coûts.
16. Les SSP doivent reposer sur des technologies coûteuses mais scientifiquement éprouvées.
17. La déclaration d'Alma-Ata a été signée par plus de 130 pays en 1978.
18. Le niveau tertiaire de la pyramide sanitaire correspond au niveau d'exécution des SSP.
19. Les SSP sont intégrés au système de santé national et liés au développement socio-économique.
20. L'approche des SSP recommande des soins spécialisés uniquement dans les centres hospitaliers universitaires.
21. La stratégie des Soins de Santé Primaires a été adoptée officiellement lors de la conférence de Bamako en 1978.
22. L'intégration intersectorielle est considérée comme un principe fondamental des SSP.
23. Les SSP visent une réduction ciblée de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile.
24. Les soins de santé primaires ne concernent que les actions curatives à l'échelle communautaire.
25. Les soins de santé primaires sont considérés comme la cheville ouvrière du système de santé.
26. La conférence internationale sur les Soins de Santé Primaires (SSP) de 2002 définit les SSP comme des « soins essentiels ».

QCM — Questions à Choix Multiples (19)

1. Parmi les propositions suivantes, choisir deux politiques préconisées à l'Initiative de Bamako :
 - A. Une politique de médicaments génériques dans chaque pays
 - B. Un système de recouvrement des coûts des actes de santé sans décentralisation
 - C. Une politique de santé à moindre coût
 - D. La mise en place des COGES pour une autonomie de gestion au niveau local
2. Les pays africains membres de l'OMS ont organisé les soins de santé primaires en plusieurs niveaux :
 - A. Trois niveaux
 - B. Cinq niveaux
 - C. Sept niveaux

3. Parmi les propositions suivantes, choisir les deux composantes essentielles des soins de santé primaires :

- A. Vaccination contre les maladies courantes
- B. Fourniture en médicaments essentiels
- C. Promotion de bonnes conditions d'hygiène alimentaire
- D. Prévention et lutte contre les endémies locales

4. Les Soins de Santé Primaires sont dits adaptés lorsqu'ils sont :

- A. Techniquement applicables, socialement acceptables et conformes aux besoins de santé des populations et aux ressources du milieu
- B. Techniquement applicables et socialement acceptables par la population
- C. Techniquement applicables et socialement acceptables avec les ressources du milieu

5. Les trois niveaux d'application des Soins de Santé Primaires, du haut vers le bas, sont :

- A. Niveaux supérieur, primaire, secondaire
- B. Niveaux supérieur, secondaire, primaire
- C. Niveaux secondaire, supérieur, primaire
- D. Niveaux secondaire, primaire, supérieur
- E. Niveaux primaire, secondaire, supérieur

6. Les trois niveaux d'application des Soins de Santé Primaires, du bas vers le haut, sont :

- A. Niveaux central, périphérique, intermédiaire
- B. Niveaux central, intermédiaire, périphérique
- C. Niveaux intermédiaire, central, périphérique
- D. Niveaux intermédiaire, périphérique, central
- E. Niveaux périphérique, intermédiaire, central

7. Le but des SSP est d'améliorer :

- A. Les conditions socio-sanitaires des populations ivoiriennes
- B. La santé des enfants avec un accent particulier sur la santé de la mère
- C. La santé de la population avec un accent particulier sur la santé de la mère et de l'enfant
- D. La santé de la population avec un accent particulier sur la santé de l'enfant

8. Les grands problèmes sanitaires identifiés par l'OMS en 1977 incluent :

- A. Le coût élevé des soins
- B. L'excès de ressources humaines
- C. Le désintérêt de la population
- D. L'équité dans la distribution des ressources

9. Relever les deux problèmes majeurs de santé identifiés par l'OMS et qui ont suscité la conférence d'Alma-Ata en 1977 :

- A. La crise économique mondiale qui rendait les pays incapables de soigner leurs populations
- B. La cherté du coût des actes de santé, ne permettant pas aux démunis de se soigner correctement et efficacement
- C. Les inégalités dans les soins
- D. Le désintérêt des populations vis-à-vis des activités des structures sanitaires

10. Le règlement sanitaire international est entré en vigueur :

- A. En 1969
- B. En 2005

C. En 1961

D. En 2007

11. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté la stratégie des soins de santé primaires en :

A. 1981

B. 1991

C. 1993

D. 1994

12. L'Initiative de Bamako a préconisé deux politiques parmi celles-ci ; lesquelles ?

A. La mise en place des COGES pour une autonomie de gestion au niveau local

B. Un système de recouvrement des coûts des actes de santé sans décentralisation

C. Une politique de santé à moindre coût

D. Une politique de médicaments génériques dans chaque pays

13. Les trois niveaux d'application de la stratégie des SSP ont été identifiés à :

A. Lusaka

B. Bamako

C. Ouagadougou

D. Brazzaville

14. Parmi les propositions suivantes, une fait partie des huit composantes essentielles des Soins de Santé Primaires. Laquelle ?

A. Vaccination contre les principales maladies infectieuses

B. Prévention et lutte contre les épidémies locales

C. Promotion de bonnes conditions élémentaires et nutritionnelles

D. Traitement des maladies infectieuses et lésions courantes

15. Parmi les propositions suivantes, choisir l'année où la Côte d'Ivoire s'est inscrite pour le démarrage des activités de mise en œuvre des stratégies des SSP :

A. 1991

B. 1994

C. 1993

D. 1987

16. Parmi les districts sanitaires suivants, choisir celui qui a servi de district pilote pour le démarrage effectif des activités de SSP :

A. Daloa

B. Bouaké

C. Bouaflé

D. Abengourou

17. Avant la mise en œuvre effective des SSP en Côte d'Ivoire, l'État a d'abord :

A. Affecté tous les personnels nécessaires à l'activité au district pilote de Bouaflé

B. Sensibilisé personnels et populations à cette nouvelle politique sanitaire

C. Formé toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie

18. Le seul principe fondamental des SSP contenu dans cette liste est :

A. L'accès universel aux soins et la couverture en fonction des besoins

B. Les activités doivent être pleinement intégrées à celles des autres secteurs de développement communautaire (agriculture, éducation, etc.)

- C. Les soins doivent avant tout reposer sur les ressources locales
 - D. Les soins doivent faire partie intégrante du système de protection sanitaire national
19. Les soins de santé primaires selon Alma-Ata (1978) doivent être :

- A. Scientifiquement valables
- B. Financés uniquement par des organismes internationaux
- C. Socialement acceptables
- D. Accessibles à toute la communauté

Chapitre 5 — Communication pour le Changement Social de Comportement (CCSC)

QCD — Questions à Choix Double (18)

1. L'information est l'ensemble des activités qui ont pour objet la collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles auprès du public.
2. La communication est un processus statique qui permet d'assurer l'apprentissage des gestes à faire.
3. Le comportement, c'est l'ensemble des pratiques propres à un individu ou à un groupe d'individus.
4. L'ensemble des manières de faire ou de pratiques propres à un individu ou à un groupe d'individus détermine son comportement.
5. CCSC est une approche nouvelle qui favorise et facilite les changements dans les connaissances, les attitudes, les normes, les croyances et les comportements.
6. La culture est un facteur environnemental susceptible d'influencer le changement social de comportement.
7. La CCSC et le plaidoyer sont un processus complexe qui nécessite une préparation minutieuse.
8. La communication pour le changement social de comportement (CCSC) est une activité qui précède toute activité de santé.
9. Le plaidoyer est un processus stratégique visant à influencer les politiques et les pratiques qui ont une incidence sur la vie des populations.
10. L'infirmier et la sage-femme doivent improviser les séances de CCSC.
11. Tous ceux qui ont le pouvoir de répondre à la demande de changement et/ou d'influer sur la société, la politique, les lois, sont la population cible du plaidoyer.
12. Le but de la CCSC est de permettre aux personnes de communiquer ou d'interagir avec les autres dans un cadre social.
13. Le canal est un des éléments constitutifs de la communication.
14. Le plaidoyer a pour but d'améliorer le bien-être de l'individu, de la communauté et de la société.
15. Les caractéristiques personnelles et psychologiques conditionnent le comportement de l'individu et influencent directement ses décisions.
16. Améliorer le bien-être de l'individu est un but du plaidoyer.
17. Identifier les décideurs et personnes influentes est l'une des étapes de la CCSC.
18. Le feed-back est la réaction du récepteur du message vers l'émetteur, ou le retour de l'information à l'émetteur.

QCM — Questions à Choix Multiples (19)

1. Parmi les propositions suivantes, choisir celle qui correspond à la définition de l'encodage dans la communication :
 - A. La constitution du message
 - B. La transcription du message
 - C. La transmission du message
 - D. La compréhension du message

2. Parmi les propositions suivantes, choisir celle qui ne fait pas partie des principes de base de la CCSC :

- A. Les valeurs humaines et citoyennes
- B. La solidarité
- C. Le partage
- D. Les minorités d'être entendues

3. Parmi ces propositions, une ne fait pas partie des éléments constitutifs de la communication. Laquelle ?

- A. L'émetteur
- B. Le récepteur
- C. Le message
- D. La méfiance

4. Les obstacles liés à l'émetteur sont (choisir les bonnes réponses) :

- A. Mauvaise perception du message
- B. Non-maîtrise du sujet
- C. Non-respect des autres
- D. Canal inadapté

5. Obstacles liés au message : choisir la bonne réponse.

- A. Message confus et imprécis
- B. Refus de message
- C. Canal indirect
- D. Codage

6. Parmi les propositions suivantes, cocher les deux obstacles liés au message :

- A. Message confus et imprécis
- B. Mauvaise attitude
- C. Message compliqué
- D. Méfiance
- E. Mauvaise perception du message

7. Les facteurs internes susceptibles d'influencer le Changement Social de Comportement sont, sauf un. Lequel ?

- A. Les caractéristiques personnelles et psychologiques
- B. Les connaissances
- C. La perception
- D. La culture

8. Cocher les deux facteurs externes susceptibles d'influencer le changement social de comportement :

- A. Les perceptions
- B. La culture
- C. Les croyances
- D. Le milieu social
- E. Les connaissances
- F. Les attitudes

9. La séance de CCSC proprement dite comporte combien d'étapes ?

A. 8 étapes

B. 4 étapes

C. 7 étapes

D. 12 étapes

10. Les étapes de la séance de CCSC sont (cochez deux bonnes réponses) :

A. Identifier les ressources

B. Choisir les partenaires

C. Énoncer le but

D. Identifier les décideurs et personnes influentes

E. Mettre en place un plan d'action

11. La question qui doit précéder la conduite d'une séance de CCSC est :

A. Quelle est la solution proposée ?

B. Quel est le problème ?

C. Sur quel thème porte la communication ?

12. Le plaidoyer a pour but de :

A. Améliorer l'accès aux soins de santé

B. Promouvoir la prévention des maladies

C. Réduire les inégalités en matière de santé

D. Renforcer les systèmes de santé

E. Toutes les réponses sont vraies

13. Parmi ces propositions, choisir celle qui montre l'importance du plaidoyer dans le domaine de la santé :

A. Promouvoir des changements de comportement favorables à la santé

B. Influencer des décideurs

C. Communiquer une stratégie

14. Les populations cibles du plaidoyer sont (choisir les deux réponses) :

A. Décideurs politiques

B. Organisations civiles nationales et internationales

C. Données probantes

15. Les étapes d'une stratégie de plaidoyer sont (cochez deux propositions) :

A. Identifier les ressources

B. Identifier les décideurs et personnes influentes

C. Faire le suivi et l'évaluation des stratégies

D. Mettre en place un plan d'action

E. Énoncer le but

16. Les époux des femmes enceintes, pour l'amélioration du taux d'accouchement assisté, représentent :

A. La population cible tertiaire

B. La population cible secondaire

C. La population cible primaire

17. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont les cibles de l'IEC/CCSC :

A. Les décideurs politiques

- B. La société
- C. L'agent de santé
- D. L'individu
- E. L'agent de santé communautaire
- F. L'ONG

18. Un groupe d'individus vivant ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion sociales s'appelle :

- A. Une communauté
- B. Une population
- C. Une cible
- D. Une association

19. La rétroaction se définit comme :

- A. Le contenu de la communication
- B. Le moyen de transmission du message
- C. Le retour de l'information à l'émetteur

Chapitre 6 — Techniques d'Animation de Groupe

Le contenu spécifique aux techniques d'animation de groupe (causerie, démonstration, jeu de rôle, etc.) n'apparaît pas dans les sujets fournis ; seule cette question de définition, à la frontière avec la CCSC, s'y rapporte.

QCD — Questions à Choix Double (1)

1. Une entité constituée tout au plus de deux personnes est un groupe.